

Krankheit	Anamnese	Status	Prozedere/ Untersuchungen	Therapie	Kommentar
Wundversorgung	Biss? Tetanus?	Inspektion Motorik Sensibilität Durchblutung	Tetanus-Impfung (im Zweifel), ev. Rabies Wundversorgung - ev. LA - Desinfektion , Reinigung + FK entfernen - Debridement, Spülen - Naht (monofil, nicht-resorb.)		Naht nur falls Wund <8h! >8h >offene Versorgung KI Naht: Bisswunde, infizierte Wunde, verschmutzte Gegenstände (Metzgermesser)
Fraktur	Unfallhergang	Inspektion Motorik Sensibilität Durchblutung	US (Sehnen, Bänder, etc.), Rx, CT (falls Gesicht/Schädel/Becken)	Je nach Fx konservativ (Gips, Schiene) od. Operativ (Osteosynthese)	
Präop-Untersuchung	Ablauf erklären Ops-Aufklärung/ Einwilligung Fragen/Ängste Kürzlich od. jetzt krank? Krankenkasse	Internistischer Status: Herz, Lunge, Abdomen, Nieren, Neuro, HNO ev., Lymphknoten	Labor (Quick, Hämät, CRP, LK, Kreatinin + je nach Ops), U-Status, EKG, Rx-Thorax , Gebietsspezifische Untersuchungen (z.B. Venenduplex bei ACB), Anästhesie (Prämedikationsgespräch), Chirurg ev.		
SD-Pathologie	Knoten? Hyper- + Hypothyreose-Zeichen erfragen, Schmerzen, Schluckbeschwerden, Heiserkeit, FK-Gefühl, Fieber, B-Symptome, Medis	Internistischer Status SD -Palpieren + Leerschluck Hals, LK Augen (Exophthal.)	Labor (CRP, LK, TSH, ft3/4, AK) US (Zyste?), Szinthi (falls Knoten >1cm und TSH <0.6 >kalt od. warm), FNP (Hyperplast. Knoten, Autonomie od. Neoplasie od. E.)	Zyste : ev. Ops od. Drainage od. nichts Autonomie : analog Basedow Hashimoto : Hormonsubstitutiaon Basedow : Thyreostatika, Radioiodtherapie, selten Ops De Quervin : Analgesie Neoplasie papilläres SD-Ca Hemithyreoidektomie, falls follikul. Neoplasie >Schnellschnitt + dann Hemi- (follikul. Adenom) bzw. totale SD-Ektomie.	Falls US f. Zyste spricht >FNP. Falls US + Labor f. Autonomie od. Thyreoiditis (Hashimoto/Basedow) spricht >Therapie. Falls V.a. Neoplasie >Szinthi + FNP. Bei benignen SD-Tumoren (Hyperplast. Knoten, Autoimmunthyreoiditis, Zyste, foll. Adenom...ist auch Verlaufsbeobachtung moeglich).

Cholezystolithiasis / Choledocholithiasis	Koliken (epigastral, in rechte Schulter ausstrahlend + ev. gürtelförmig), ev. Fieber Trigger Ernährung, 6 F (female, blonde, forty, fat, fertile..),	Inspektion Auskultation Palpation: <i>Murphy-Z., Courvoisier-Z., Abwehrspannung,</i>	Labor: LK, CRP, Bilirubin, ALAT, ASAT, γ-GT, ALP US Oberbauch Rx-Abdomen Bei Gallengangssteinen auch ERCP (gleichzeitig Dx. + Th.) od. MRCP (nur Dx)	<u>Cholezystolithiasis</u> Laparoskop. Cholezystektomie , selten offen-chirurgisch Aber: Th. nur falls symptomat. Steine! <u>Stein in Gallengang:</u> immer Th. >ERCP od. chirurgisch	DD: akute Cholezystitis (E. wegen Stein meist >Cholezystektomie M.d.W.) Murphy: Pat. soll tief inspirieren >unter rechten Rippenbogen palpieren >Sz. wenn Cholezystitis Courvoisier: Prall-elast. tastbare GB (oft bei Tumor, auch bei Stein)
Nierenstein	Flankenkolik (ausstrahlend Leiste), ev. Fieber, ev. Hämaturie Trigger: Exsikkose, Ernährung	Abdomenstatus 8 Inspektion, Auskultation, Palpation, hier besonders auf Nierenlogen Wert legen, Rektaluntersuchung),	U-Status (Hämaturie, Sediment) US (Stein/Schatten, dilat. N-Becken) CT Ev. noch Labor	Kleine Steine (<6mm) abwarten Medikamentöse Auflösung (gew. Steintypen) Stosswellenlithotripsie (>6mm), auch endoskopisch od. via Hautschnitt möglich	
Akute Pankreatitis	Plötzliche heftigste S, Dauer-Sz., vernichtend, gürtelförmig ausstrahlend, diffus z.T., Übelkeit, Erbrechen, Meteorismus, Fieber, Schock-Zeichen, Gesichtsrötung, Trigger: Alk, Gallensteine, Medis	Abdomen (Meteorismus, ev, Aszites, prall-elastisch, diff. Druck-Sz., ev. Peritonitis, Cullen-Zeichen) Leiste Nierenlogen	Vitalparameter, PVK Labor (Amylase, Lipase, Elastase, CRP, LK, LDH, Leberwerte, BB, Kreatinin) U-Status (Lipase erhöht) US, Rx-Abdomen/Thorax, CT, MRCP/ERCP (bei V.a. biliäre Genese) Ev. FNP	Konservativ: Intensivstation >O2, Analgesie, PPI (gg. Stressulkus), Volumengabe, Monitoring, Nüchternheit, Thromboseprophylaxe, Magensonde, DK, AB Ops/Intervention ERCP wenn Obstruktion, Cholezystektomie falls biliäre Pankreatitis. Nekrossektomie falls Nekrosen.	Cullen-Zeichen: periumbilikal bläulich-grünliche Flecken
Divertikulitis	Sz. li. Unterbauch (selten mittlerer UB), schubartig, zunehmend	Abdomen untersuchen (Inspektion, Palpation 4 Quadranten >Druck-Sz + ev. Abwehrspannung, Milz, Leber, Niere, Auskultation) Nierenlogen Lymphknoten	Klinische Dx Labor: LK, CRP, Hämät Bildgebung: - Abdomen-Leer-Rx (stehend) - Gastrografen-Schluck (GIT-Passage) od. Einlauf (Colon) - ev. Abdomen-CT - ev. Koloskopie, ev. Endoskopie v. proximal, ev. Thorax-Rx	Konservativ: Ballaststoffe, Drainage falls Abszess Chirurgisch: laparoskop. Od. offene Divertikel-Abtragung, ev. Sigma-Resektion (wenn dort lokalisiert + multipel, laparoskopisch)	Meist Sigmadivertikulitis. Divertikulitis = E. v. Divertikeln. Kann auch im Magen, Duodenum, etc. vorkommen! Meckel-Divertikel (meist asympt. im Dünndarm, embryonal-bedingt)
Hoden/Ovartorsion	plötzlich auftretenden stärksten Schmerzen, oft auch in Nacht	Inspektion: Hoden geschwollen + gerötet Palpation: Prehn-Zeichen neg. * Lymphknoten	BE US, im Zweifel operative Freilegung d. Hodens	Ops (Detorquierung + Orchidopexie) Bei Frauen: Laparoskopie	Positives Prehn-Zeichen (Heben d. Hodens bringt Erleichterung >V.a. Epididymitis)

Appendizitis	Oberbauch-Sz. (epigastral, schlecht lokalisierbar, dumpf) >wandern in re. Unterbauch (gut lokalisierbar, scharf), Erbrechen/Übelkeit, Fieber, Stuhl/Wind/Urin erfragen	Inspektion (angezogene Beine/Schonhaltung, Palpation: 4 Quadranten (li. beginnen), Mc Burney, Lanz-Punkt, Loslass-Sz./gekreuzter LS, Abwehrspannung od. Defense musculaire*, Psoas-Zeichen Auskultation LK Rektale Untersuchung (Sz.?) F. Gynäkolog. Status	Fiebermessung Labor: LK, CRP, Hämat U-Status US (verdickte Appendix, Ödem/E.) (Ev. Abdomen-Leer, CT) Dx Unsicher: abwarten + beobachten, Abführen, weitere Dx (CT)	Laparoskop. Appendektomie, selten offen , wenn keine Ops möglich AB Mc Burney: Druck-Sz. zw. beiden ässeren Dritteln, der Verbindungslinie zw. der re. Spina eil. + Nabel Lanz: Druck-Sz. 5 cm medial der re. Spina (Verbindungslinie zw. beiden Spinae) Gekreuzter L-Sz.: falls Sz. im Appendix-Bereich wenn Loslass-Test auf gesunder Seite gemacht wird Psoas-Zeichen: Sz. im re. Unterbauch bei Flexion des re. Beines in Hüfte gg. R. Defense-M: Muskulatur zieht s. reflexartig zusammen beim Palpieren (nicht willkürlich), will Peritoneum schützen bzw. Sz-Auslösung vermeiden. >Peritonitis-Zeichen Abwehrspannung: entsteht weil Pat. sieht, dass Palpation erfolgen wird >kein Peritonitisches Zeichen.	
Ileus	Kolikartige Bauch-Sz., Erbrechen, Übelkeit, starke Peristaltik, aufgetriebenes Abdomen, Stuhl- + Wind-Verhalt, Urin erfragen Trigger: Voroperationen, Adhäsionen, Briden, Hernien, Tumor, FK, Gallensteine, Medis etc.	Inspektion: Turgor (Haut, Mukosa), Narben, Hernien Auskultation (mechan: metall. Peristaltik, paralyt: Totenstille) Palpation (Blähung) Rektale Untersuchung	Labor (CRP, LK, Hämat., Kreat., Harnstoff, Elektrolyte, Säure-Basen, Protein), US (Peristaltik, Dilatierter Darm), Abdomen-Leer-Rx (stehend od. li-seitenlage >erweiterte Schlingen, Flüssigkeitsspiegel, Luft im Dünndarm), Gastrographin-Test, CT	Konservativ (v.a. bei paralyt. I.): Magensonde, PE, ZVK, DK, Anregung Darmtätigkeit Chirurgisch (v.a. bei mechan. I.): mechan. Hindernis beheben	
CED/ IBD	CU: blutig-schleimiger Durchfall, Arthralgien, ev. Augensymptome (Uveitis, Skleritis), subfebril, schlechter EZ, Schmerzen, GW-Verlust, z.T. reaktive Arthritis Crohn: Abdominal-Sz (>re Bauch), blut-schleimige Diarrhoe (meist ohne Blut), Flatulenz, Krämpfe, GW-Verlust, subfebril,	Abdomen, LK, Herz, Lunge Rektaluntersuchung	Labor (CRP, LK, BB, BSG) Haemocult -Test ev., Stuhlprobe (Calprotectin, Parasiten) Kolo-Ileoskopie mit Biopsie (mind. 5 an versch. Abschnitten) US Kolondoppelkontrasteinlauf	Crohn: Substitution Fe/B12/Vitamine..falls Magel, Nikotinstopp, top. od. syst. Steroide/ Budesonid , Immunsuppressiva/ Azathioprin , Biologicals/ Remicade , Psychologie CU: Substitution Mängel, Nikotinstopp, 5-Aminosalizylsäure , syst. Steroide/ Prednisolon , Immunsuppressiva/ Azath. Psychologie	Crohn: ganzer GIT, transmural, Granulome, segmentaler Befall, nicht heilbar CU: Colon (distal zunehmend), oberflächlich, diffus ganzes Colon, heilbar Beide: Chirurgisch/Endoskopisch: CU: Proktokolektomie (Ileao-Anale Anastomose) Crohn: minimalchirurgie (Abszesse, Stenosen, Fisteln, Blutung, Perf.)
SHT	Erbrechen, Kopfschmerzen, Amnesie, neurolog. Ausfälle, Hämatom, Bewusstseinverlust, Lähmung, Urin/Stuhlabgang,	Neurostatus (GCS, Pupillen, Hirnnerven, Motorik, Sens., Kraft) Hirndruckzeichen: motor. Unruhe, Bewusstseinsverschlechterung, hoher syst. BD, areaktive Pupillen, Bradykardie, schwallart. Erbrechen	PVK, Analgesie, ev. Antiemetika CT (Schädel + WS ev.), ev. MRI Bettruhe & Überwachung	Wundversorgung Analgesie Je nach Ursache: - Subdurales/epidurales/ intrazerebrales Hämatom: Bohrlochtrepanation -: Kraniotomie - Hydrocephalus: Shunt - Etc.	

Spinalkanalstenose	Claudicatio-Sz., Verkürzung Gehstrecke, ein- od. bds.	Neurostatus (Sens/Dermatome, Kraft, Tonus, Reflexe) WS-Untersuchung (Gang, Beweglichkeit)	MRI	Dekompression/Entlastung	
Diskushernie/Radikul. Sy	Lumbal od. Cervical , Schmerzen (oft bei heftigen Bewegungen od. Heben v. Lasten), Ruhe-Sz., Nacht-Sz., AZ, Fieber, Steifhaltung, Flexion wirkt meist verstärkend, z.T. starke Lähmungserrscheinungen (Blase- + Rectum, Sensibilität, Paresen), Hexenschuss/Lumbago, starke neurolog. Ausfälle, B-Symptome, Trauma	Neurostatus: Dermatome/Sens., Reflexe, Kraft, Tonus, Lasegue WS-Untersuchung (Inspektion, Finger-B-Abstand, Schober/Ott, Beckenschiefstand, Trophik, Bewegungen, Palpation, Lasegue, Sensibilität) Nierenloggen	Rx, Myelographie, CT od. MRT	Konservativ: strikte Bettruhe + Analgetika/NSAR Paar Tage (falls Anfall), Muskelrelaxans , Halskragen, Wärmerotherapie/applikation, Physio, Triggerpunkt-Th Instruktion f. Verhalten/Bücken/Heben Chirurgisch: Bandscheibenprothese, Dekompression	Lasegue: Flexion gestrecktes Bein in Hüfte >reizt komprimierte Nervenwurzeln d. Ischiadicus, meist + bei lumbaler DH. Dermatome + Reflexe anschauen!
Pneumothorax	Asymptomatisch od. stechender Sz. Brustwand, Tachykardie, BD-Abfall, plötzliche Dyspnoe, Zyanose Trigger: Spontan, Trauma, Lungenerkrankung, iatrogen (ZVK)	Inspektion: Atemfreq., Symmetrie Thoraxhebung, Zyanose, Wunde, Auskultation (AG abgeschwächt), Perkussion (hypersonor)	Rx-Thorax , selten CT Bei V.a. Spannungspneu keine Dx >direkt Drainage legen!	Thorax-Drainage (Luft muss raus)	
KHK: AP/Infarkt	AP-Beschwerden , retrosternales Drücken/Ziehen/Stechen, Ausstrahlung li. Arm/Schulter/Hals, in Ruhe od. bei Belastung, hilft Nitroglycerin? V.a. Infarkt: Vernichtungs-Sz., Kaltschweiss, Nitro hilft nicht, RF's, Schwäche, Angst, vegetat. Zeichen (Schwitzen, Übelkeit, Erbrechen) RF's + Trigger: Hypertonie, DM, Dyslipidämie, Adipositas, Alkohol, Rauchen, +FA, Kälte, Postprandial, Stress/Psychie DD: LE, Aortenaneurysma, Aortenruptur	AP: Kardiestatus V.a. Infarkt: sofort Dx machen! Nebenbei aber Kardiestatus + Neurostatus kurz	AP: Nitroglyceringabe, EKG, Herzenzyme, Koronarangiographie, Belastungs-Ergometrie, Langzeit-EKG, Myokardperfusions-Szintih, PET, CT V.a. Infarkt: Monitoring, O2, Nitroglycerin-Gabe, Heparin, ASS, PVK + BE (CRP, BZ, BB, Troponin I und T, CK-MB), EKG (ST-Hebung, neue Q-Zacken), Koronarangiographie, Echo, selten MRT MONA!!!! (Morphin, O2, Nitroglycerin, Aspirin)	Stabile AP: Therapie RF's, Nitroglycerin (lingual), ASS + ev. B-BI. + ev. Statin , Instabile AP: Ischämietests (Belastungs-EKG, Myokardszinti...) >falls + >Koro + elektive PTCA od. Bypass STEMI: Thrombolyse (Streptokinase) od. Koro >PTCA/Bypass NSTEMI: Korolabor >PTCA/Bypass	AP-Klass. >CSS: 0 körperl. n. eingeschränkt, 1 leicht, 2 deutlich (bereits bei 1-2 Stockwerken), 3 bei leichter Belastung od. Ruhe, 4 bei jeder Belast. od. in Ruhe H-Insuff-Klass. >NYHA: I Keine Einschränkung, II bei stärker Belastung, III bei leichter Belastung, IV in Ruhe Instabile AP: AP verschlimmert sich oder jede neue AP NSTEMI: keine ST-Hebung, aber – senkung, Enzymveränderungen STEMI: ST-Hebung mit Enzymveränderungen (Trop. U.a.) >klass. AMI

PAVK	Claudicatio intermittens/Sz. (Waden, Oberschenkel), Verkürzung Gehstrecke, RF's: Hypertonie, DM, Dyslipidämie, Adipositas, Alkohol, Rauchen, +FA	Inspektion (Trophik, Nekrosen, Gangrän, Farbe) Palpation (Temperaturunterschied, Pulse, Rekap) Auskultation Herz-Status	Art. Ausmessung/Doppler (Fluss als Geräusch), Duplex-Sonographie (Blutfluss farblich) ABI Ratschow-Test (Beine), Allen-Test (Arme) Ev. Angio (intra-art. od. MR/CT) ev. Carotis-Duplex	<u>Stadien I-IIa</u> Therapie RF's ASS, Plavix Gute Schuhe + Gehtraining <u>IIb-IV</u> PTA + Stent (endovaskulär) od. chirurgischer Bypass, ASS, Plavix	La-Fontaine I: Asympt. IIa: falls >200m IIb: <200m III: Ruhe-Sz. IV: Nekrose/Gangrän Ratschow-Test: Pat. tätigt Wadenmuskulatur durch schnellen Kippen d. Füße in Rückenlage >schnell Aufsitzen + Beine hängen lassen >normal sollte nach 10-20 s Reperfusion erfolgen
Varizen	TVT gehabt? Durchblutungsstörungen? Hypertonie, BG-Schwäche, Familie, viel Stehen/Sitzen RF's: Hypertonie, DM, Dyslipidämie, Adipositas, Alkohol, Rauchen, +FA	Inspektion: Im <u>Stehen</u> untersuchen! Stamm-, Seitenast-Varizen, Retikuläre V., Besenreisser (blaue od. rote) CVI-Zeichen: Stauungsekzem, Ödeme, C. phlebectatica, Hypodermatitis/Pseudoerysipiel, Stauungspurpura, Hyperpigmentierung, Dermato-Lipo-Faszio-Sklerose, Atrophie blanche, Ulkus od. abgeheilt Insuff. tiefes Venensystem. Zeichen v. Postthrombot. Sy. suchen (schlechte Mikrozirkul., Art. Gefäßstatus (art. Problem z.B. PAVK ausschliessen) Neurostatus (Polyneuropathie, DM, etc.	BE (RF's), Venen-Duplex/Mapping ev. mit Farbdoppler ----- <u>Reikul. V.:</u> <3mm, subkutan, bläulich, netzartig (kosmetisch) <u>Besenreisser:</u> <1 mm blau, <0.4 mm rot <u>Crossektomie:</u> falls Insuff. d. 1. Klappe in Leiste wo Mündung ins tiefe V-System. F <u>Stripping:</u> bei Stammvarizen	1. Prophylaxe: Muskelpumpe/Bewegung, Hochlagern, Kompressionsstrümpfe* Kl. I-II reicht, kalte Dusche 2. RF's therapieren: Gewichtreduktion, Sport, Rauchstopp, Hypertonie-Th., Sitzen/Stehen vermindern 2. Medis (venöser Rückfluss), Daflon, Aspirin, Prostagl. E 3. Varizen-Ops falls Varizen: Crossektomie, Stripping, Miniphlektomie (Seitenast-V. + retikul. V.), Skleroth./Laser (Besenreisser) Ulkus cruris siehe DERMA-Szenarien	
Brust-Knoten	Siehe Gyni				
Hiatushernie	Sodbrennen, retrosternales Brennen, Magenbrennen, Dysphagie, Aufstossen, Speichel-Überfluss, FK-Gefühl, epigastr. Sz. Trigger: Adipositas, Erbrechen, Schwere Heben, SS, Trauma, kongenital, iatrogen/Ops	Abdomen Mund/Rachen, Laryngoskopie, Kardiostatus, Lungenstatus,	Gastrographin-Breischluck (Rx), Endoskopie, pH-Metrie (Aus-/Einschluss GERD)	Abwarten falls keine Symptome, falls GERD >PPI, falls starke Symptomatik Chirurgie	

Ösophagusproblem	Sodbrennen, retrosternales Brennen, Magenbrennen, Dysphagie, Aufstossen, Speichel-Überfluss, FK-Gefühl, Sz., im Liegen Verschlimmerung meist, ev. Dyspnoe, Schluckauf, Husten, Heiserkeit, Halsweh, Odynophagie, Meteorismus, Flatulenz, B-Symptome Trigger: Adipositas, Erbrechen, Schwere Heben/Pressen/ Bücken/ Rückenlage, Anstrengung/Sport, SS, Trauma, kongenital, iatrogen/Ops, Ernährung (Fett, Alk, Kaffee)	Abdomen Mund/Rachen, Laryngoskopie, Kardiostatus, Lungenstatus,	Endoskopie (ev. Biopsie, Abstrich*), Breischluck (Rx), Endo-US, CT Funktionell: pH-Metrie (GERD), Manometrie (Motilität), Gallenreflux-Messung (Duodeno-Reflux), Allergie-Tests (eosino. Ö.) *infektiöse Ösophagitis	Motilitätsprobleme (Achalasie, Spasmen, Nussknacker, A-Ring (muskulär), Schatz-Ring (Schleimhautausstülpung)): GERD, Nitroglycerin, Anti-Depr., Botulinus, Ca-Kanal-Bl., M-Relaxans, Dilatation, Myotomie Stenosen: Dilatation/Ballon, Stent, Laser GERD: RF (Fett, Alk, Kaffee, Nikotin, Adipositas) therapieren, konserv. Massnahmen (kl. Malzeiten, Kopfteil hochstellen im Bett, Rechtsseitenlage), PPI/Nexium, ev. H2-Blocker/Ranitidin od. Antazida/Rennie, selten endoskop. Od. chirurg. Antireflux-Th., Barett: Endoskop. Od. chirurg. Entfernung Tumoren: Chirurgie, ev. Palliativ Divertikel (Zenker (Pseudodivertikel), Traktionsd.(echtes Divertikel)): falls symptomatisch >endoskop. Spaltung, chirurg. Myotomie FK: endoskop. Entfernung Ösophagitis: AB, Antimykotika (Pilz), Antiviral (CMV i.R. HIV,HSV falls Immunsupr. Sonst keine Th.), Antihistaminika, inhal. CS schlucken (eosinophile Ö.) Blutung: Haemodyn. Stabilisierung, endoskop. Blutstillung >Sklerosierung, Epinehrin, Elektrokauter, Ö-Varizen: Stabilisierung, Octreotid od. Vasopressin, Ligatur od. Sklerosierung
Akutes Abdomen	Akute Bauch-Sz., Vernichtungs-Sz., bretttharter Bauch, peritoneale Symptomatik (Druck- + vibrationsempfindl. Bauchdecke), Fragen: Beginn (akut od. schleichend), Typ (Kolik, Dumpf, Dauer-Sz), Intensität, Ort, Ausstrahlung, Verschlechterung, Besserung, Begleitzeichen, Fieber, Durchfall, Erbrechen, Ernährung, Wo Begann Sz., Veränderung, Koliken, diffus od. lokalisierbar, gynäkolog. Anamnese, Ulkus, Gallensteine,	Inspektion (Unruhe, Schonhaltung, Kolorit, Atmung, Ausdruck, Narben, Bruchpforten) Palpation (4 Quadranten, Klopf- + Loslass-Sz., Meteorismus, Resistenzen, Bruchpforten, Abwehrspannung, spez. Druckpunkte f. Append./Gallenbl./etc., Leber, Milz, Nieren) Auskultation Nierenloggen Lymphknoten Herz & Lunge Rektale + gynäkolog. Untersuchung	Fiebermessung, Vitalparameter, PVK + Labor (BB, CRP, LK, Elektrolyte, Pankreas-Amylase + -lipase, Bilirubin, ALP, y-GT, Kreatinin, Troponin, CK-MB), BZ-Test, SS-Test (Frauen), Urin-Status Bildgebung: US, EKG, Rx-Leer (stehend od. li-Seitenlage), Rx-Thorax (ap stehend), CT, zusätzliche Bildgebung* Massnahmen bis Dx klar bzw. Therapieentscheid/Ops: O2, Analgesie, PPI (gg. Stressulcus), Volumengabe, Monitoring, Nüchternheit, Thromboseprophylaxe, ev. Magensonde, ev. DK, ev. AB Therapie: <u>Superakutes Abdomen:</u> Abdominal-Sz. + Schock >sofort Chirurgie denn wahsdchl. EUG/Blutung/Aneurysma <u>Akutes Abdomen:</u> Abdominal-Sz. + general. Peritonitis >Ops innert 6h (perf. Appendizitis, Divertikulitis, Colon-Perf., NSAR-Colitis, etc.). Bei lokalisierter Peritonitis (meist Cholezystitis, Appendizitis + Divertikulitis) ev. konservative Th. (Analgesie, AB) + Beobachten od. Ops (>6h möglich). *Ev. <u>Gastrografinpassage od. Kolon-Einlauf</u> (V.a. Motilitätsproblem, Stenose/Obstruktion), <u>CT</u> (Pankreatitis, Aneurysma, feie Flüssigkeit, Verletzungen, Frakturen, Tumoren, Abszesse), <u>Angio</u> (V.a. Blutung, Stenose, Infarkt), <u>Endoskopie</u> (V.a. Ulkus, Varizen), <u>Laparoskopie</u> (Dx-Sicherung + gleichzeitig Th >Appendektomie, Cholezystektomie)	Viszeraler Sz/Organ-Sz.: Diffus, dumpf, oft Epigastral, verstärkt durch Palpation, Begleitsymptome (Nausea, Schwitzen, Unruhe) <u>Parietaler Sz./Perit. Parietale:</u> gut lokalisierbar, scharf, peritonit. Zeichen (Defense, Loslass-Sz., etc.) DD: AMI, Appendizitis, Divertikulitis, Cholezystitis/Cholezystolithiasis, Urolithiasis, Ileus, akute Gastroenteritis, Pankreatitis, Adnexitis, Ovar/Hoden-Torsion, EUG, Ovulations-Sz., M. Crohn, C. ulzerosa, Endometriose, Aortenaneurysma-Ruptur, etc. Ileus: Spiegelbildung Dünn- + Dickdarm bzw. stehende Schlingen Perforation: Luft ausserhalb Darm (Dünndarm enthält prakt. keine Luft!)

Magen/Duodenum-Ulkus	Epigastrische Sz. (Mitte Oberbauch meist), v.a. nüchtern + nachts, Übelkeit, Erbrechen, chronisch, Nahrungsaufnahme lindert, ev. Hämatemesis Trigger: Säure, Stress, Rauchen, Alk, Medis/NSAID, H. pylori, etc.		Gastroduodenoskopie mit Biopsien (Ausschluss Malignom, Präkanzerose) Pylori-Test (Atemtest od. Nachweis im Stuhl)	Konservativ Nikotinstopp + Trigger reduzieren, Pylori-Eradikation mit Tripple-Th., PPI/Nexium Chirurgisch Bei V.a. Malignom od. Komplikation (Perf., Blutung), Exzision od. Teilresektion od. Vagotomie (Säureprod. Sinkt)	DD: Perforation Tripple-TH: PPI + 2 AB über 7 Tage
Leistenhernie	Anhaltende Sz. im Hernienbereich, ev. Stuhlverhalt, Schwellung/Vorwölbung, Verstärkung bei Belastung/Sport/Pressen/Husten, im Liegen/Ruhe Besserung, DD: Nephrolithiasis	Transskrotale Austastung des äusseren Leistenrings beim Pressen od. Husten (Seitenvgl.), Untersuchung Abdomen (Insp., Palp. Auskult.) Direkte Hernie an Fingerbeere, indirekte an Fingerkuppe	US, Diaphanoskopie falls Skrotalhernie	Chirurgische Reposition + Netz-Einlage	Bruchpforte, Bruchsack + Bruchinhalt beurteilen Direkte/Mediale L-Hernie: penetriert medial d. epigastr. Gefässe durch äusseren Leistenring die Bauchwand. Indirekte/Laterale L-Hernie: lat. der. Epig. Gefaesse, penetriert dem Leistenkanal folgend schräg durch Bauchdecke Skrotal-Hernie: Bruchinhalt wandert bis ins Skrotalfach Femoralhernie: Bruchsack tritt durch Lacuna vasorum medial d. Femoralgefässe unterhalb Leistenband >tiefer als Leistenhernie.

Immer fragen: Stuhl, Urin, Wind, Ernährung, Übelkeit, Erbrechen, Sz., Fieber, etc.

ANAMNESE: 6 Dimensionen; PA, FA; RF's (Hypertonie, DM, Rauchen, Alkohol, Adipositas, Dyslipidämie, +FA), **Medis; Allergien, B-Symptome, LK**